

## 손 습진 스테로이드 연고 효능 순서

손바닥은 각질층이 두꺼워 안면처럼 약하게 시작하면 실패하기 쉽습니다. 급성 악화는 충분한 역가로 짧게 조절하고, 호전되면 중등도 제제로 낮추어 재발을 막는 흐름이 핵심입니다.



### 부위별 시작점과 사용량

|                                         |                                    |                                        |                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 두꺼운 손바닥<br><b>Class 1-2</b><br>급성·각화 병변 | 손등·굴측<br><b>Class 3-4</b><br>중등도부터 | 급성 조절 기간<br><b>1-2</b><br>주 burst 후 감량 | 한 손 1회 도포량<br><b>1 FTU</b><br>약 0.5 g |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|

### 강한 순서대로 보는 외용 스테로이드

| 역가                  | 성분                                                               | 공급 O 확인 제품명                                                                                                                                                                      | 손 습진에서 쓰는 자리                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>1</b><br>초강력     | <b>Clobetasol propionate 0.05%</b><br>US Class 1                 | 더모베이트연고, 도모호론연고/크림, 베타베이트연고/크림, 프로솔로션/연고<br>두피액·샴푸 제형은 손 습진 표에서 제외                                                                                                               | 손바닥 급성 악화·두꺼운 각화·갈라짐.<br>짧게 충분히 쓰고 호전 즉시 step-down. |
| <b>1-2</b><br>매우 강함 | <b>Diflucortolone valerate 0.3%</b><br>국내 분류상 very potent/potent | 디푸코로션0.3%, 디푸코연고0.3%<br>항진균 복합: 라파엘크림, 트라보코트크림                                                                                                                                   | 손바닥·손가락 측면의 두꺼운 병변.<br>넓은 면적 장기 사용은 피함.             |
| <b>2-3</b><br>강함    | <b>Desoximetasone 0.25%/0.05%</b><br>데타손은 이 성분                   | 데라파손로션, 데속시원겔0.05%, 데속손겔0.05%/로션0.25%,<br>데타손로션0.25%/연고0.25%, 메타파손겔, 에스파손겔0.05%/로션0.25%,<br>제이데속시겔0.05%                                                                          | 손바닥·두꺼운 손가락 병변. 1차 조절<br>또는 초강력제 이후 전환.             |
| <b>4</b><br>중등도     | <b>Methylprednisolone aceponate 0.1%</b><br>medium potency       | 아드반탄연고/크림, 토피솔밀크로션, 프레반탄연고                                                                                                                                                       | 덜 심한 flare, 손등·손가락 굴측, 조절<br>후 step-down.           |
| <b>4</b><br>중등도     | <b>Mometasone furoate 0.1%</b><br>간헐 유지 근거가 있는 중등도 제제            | 더메타손크림, 더모타손엠엘로션/크림, 더미손크림, 라벨리아로션/크림,<br>메이손로션/크림, 메타손크림, 모리코트로션/연고/크림, 모메담크림, 모메손크림,<br>모메솔크림, 모메스킨크림, 모메코트크림, 모메타뉴크림, 모메탄크림, 모멘타로션/<br>연고/크림, 모멘타손크림, 모멘타솔크림, 모멘트로션, 모타손로션/크림 | 손등·얇은 부위, 만성 재발의 간헐<br>유지. 얼굴·접히는 부위는 더 낮게.         |
| <b>6</b><br>약함      | <b>Desonide 0.05%</b><br>low potency                             | 나리소로션0.05%, 데소나로션0.05%/크림0.05%, 데소니아로션0.05%/크림0.05%,<br>데소니움로션0.05%, 데소담크림0.05%, 데소웬로션0.05%,<br>데스원로션0.05%, 마일드원크림0.05%, 아토맥스로션0.05%/크림0.05%,<br>제스원크림, 케어담로션0.05%, 토피담로션0.05%   | 안면·얇은 피부·마무리용. 두꺼운<br>손바닥 1차 치료로는 대개 부족.            |

### 치료 단계별 처방 흐름

|                                                                          |                                                                               |                                                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. 급성 악화</b><br>손바닥: 초강력·강력 연고를 1일 1-2회.<br>야간: 보습제 후 면장갑, 필요 시 폐쇄요법. | <b>2. Step-down</b><br>홍반·가려움·균열이 줄면 중등도 제제로 낮춤.<br>갑자기 끊기보다 3-7일 간격으로 횟수 조절. | <b>3. 절약·유지</b><br>반복 재발: 주 2-3회 간헐 유지 고려.<br>TCl: 프로토팩·토피크로·타크로연고, 엘리델크림. | <b>4. 난치성</b><br>강력 TCS 4주에도 중증이면 피부과 의뢰.<br>알리트레티노인 10/30 mg: 지질·임신 모니터링 필수. |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

### 같이 해야 약이 듣습니다

|                                                                       |                                                                   |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>장벽 회복</b><br>무향 보습제를 손 씻은 직후와 취침 전 반복.<br>각화가 두꺼우면 urea 10% 크림 병용. | <b>자극 차단</b><br>마른 작업은 면장갑, 젖은 작업은 비닐·니트릴 장갑.<br>장갑 안이 젖으면 바로 교체. | <b>재평가 신호</b><br>진물·농·통증 증가, 진균 의심, 2주 치료 반응 부족.<br>난치성은 접촉피부염 감별·접촉검사. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

검색 기준: 약학정보원 성분별 상세검색에서 공급유무 O, 피부 도포 제형(연고·크림·로션·겔)만 반영했습니다. Betamethasone valerate/dipropionate 복합제는 감염·진균·건선 적응증 확인 후 별도 선택합니다.

